SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO UF0131



U.F. 0131:

Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.

UNIDAD FORMATIVA 3: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES (UF0131; 50 horas)

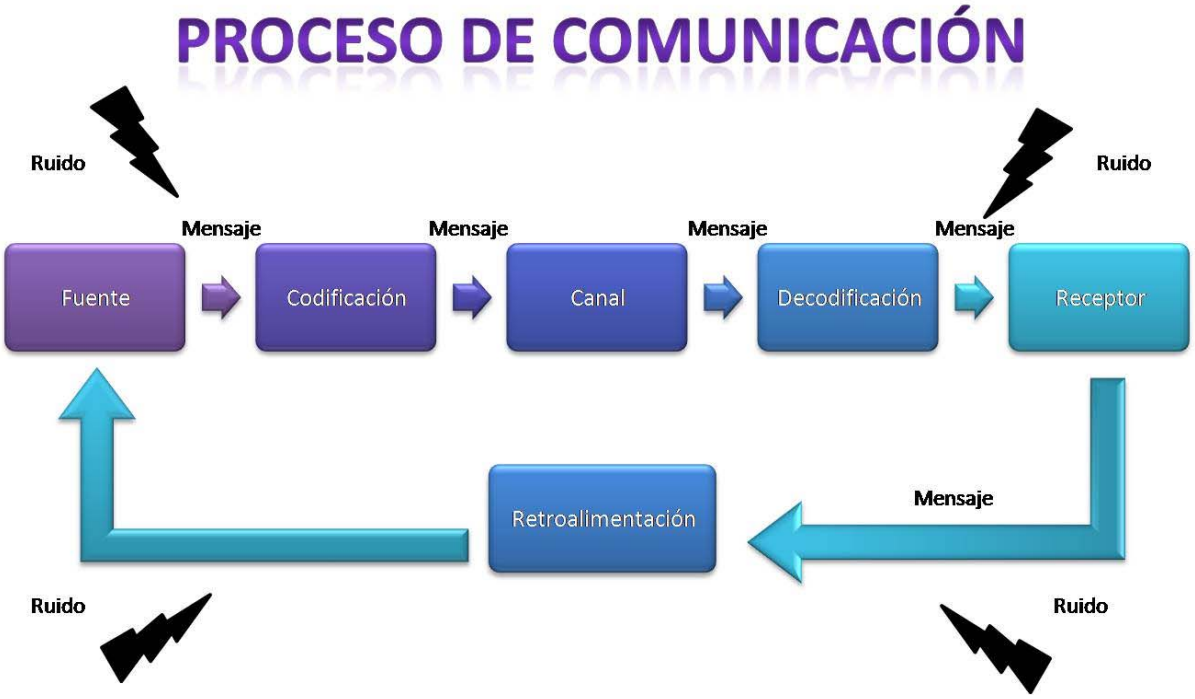


Contenidos

1. Mejora del proceso de comunicación con la persona usuaria

1.1.- Proceso de comunicación; características.

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.



Además del lenguaje como tal, verbal, coexisten otros elementos a la hora de la comunicarse y estos son los medios no verbales y paraverbales.

COMUNICACIÓN VERBAL

Es el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje propiamente tal, expresado de manera hablada o escrita. Es aquí cuando recordamos a los factores de la comunicación, pues es el sustento de la misma: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto (por mencionar a los más importantes y los que sirven de base fundamental).

Características

- se utiliza el canal auditivo
- se capta por medio de la percepción,
- Es espontánea
- se puede retractar
- Es efímera
- Hay interacción
- Utiliza soportes verbales y no verbales (movimiento de manos, gestos varios)
- Posee sintaxis diversa, muy elaborada o no (uso de “muletillas”)
- Es posible escribirla
- Es lineal, o sea, no se pueden decir o leer dos letras al mismo tiempo

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Habitualmente para comunicarnos utilizamos una serie de elementos que apoyan nuestras ideas y le dan significado a lo que expresamos. Estos factores se enmarcan dentro de lo que no es verbalizado por el lenguaje hablado. Son los que se presentan a continuación:



- *Lenguaje Kinésico*: son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean concientes o inconcientes. En ocasiones estos gestos hablan mucho más que las propias palabras, es así, que si se dice estar interesado en un tema específico, pero el rostro está diciendo lo opuesto y la expresión de éste es de aburrimiento… podemos concluir que la persona se contradice y que realmente no está pendiente de la exposición.

- *Lenguaje Proxémico* es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano. Es la cercanía o distancia que se tiene al comunicar, cuán lejos o próximo se está del otro y esto depende del grado de confianza y del tipo de interacción que se quiera entregar. De esta forma será distinto el acercamiento entre dos amigos que dialogan y se conocen, que un emisor hablando a un grupo de oyentes en una conferencia, donde estará en un o escenario lejano al público. Ahora bien, hay ocasiones en que la proximidad no se puede evitar, aun cuando los que nos rodean no nos sean cercanos y esto ocurre en la locomoción colectiva, el las filas de los bancos, recitales de música o en los ascensores.

- *Lenguaje Icónico* son las imágenes de los objetos, su representación simbólica. Poseen una doble dimensión, esto es que una ilustración, que se entiende es gráfica, también tiene una explicación escrita. Pertenecen a este lenguaje la señalética vial, de tránsito, los letreros que vemos en las calles de la ciudad, los medios de comunicación escritos, sean afiches o publicidad; las obras artísticas: esculturas y pinturas.

COMUNICACIÓN PARAVERBAL

Son los elementos anexos al proceso de comunicación, que intervienen en él y le dan sentido al mismo. Acá se encuentran la entonación de la voz, las pausas que hacemos al hablar, el ritmo de nuestras palabras y el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente. Dentro de lo escrito se hallan los elementos de gramática y ortografía puntual, también el tamaño de las letras a usar, el formato del texto y la distribución de éste en la hoja o base donde se colocarán las palabras.

1.2.- Barreras en la comunicación, interferencias y ruidos.

Aún cuando el emisor y el receptor pongan todo de su parte para lograr comunicarse eficientemente, existen INTERFERENCIAS que pueden rebasar el control que se pretenda, limitando la comprensión del mismo. Parte quizá de nuestra condición humana o parte quizá de las circunstancias ambientales externas que salen de nuestro control, van a impedir una comunicación 100 % eficaz y eficiente, estas causas de interferencia son las BARRERAS**.**

Durante el proceso de comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que es necesario detectar para evitarlos y lograr una comunicación eficiente; a dichos obstáculos se les denomina como barreras de comunicación y se clasifican en:



A) barreras semánticas: el emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje.

B) barreras físicas: son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc.

C) barreras fisiológicas: son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) o del receptor (sordera, problemas visuales, etc) que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación.

D) barreras psicológicas.- Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales (temor, odio, tristeza, alegría) o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee.

E) barreras administrativas: La estructura y el funcionamiento de la organización da lugar a problemas.

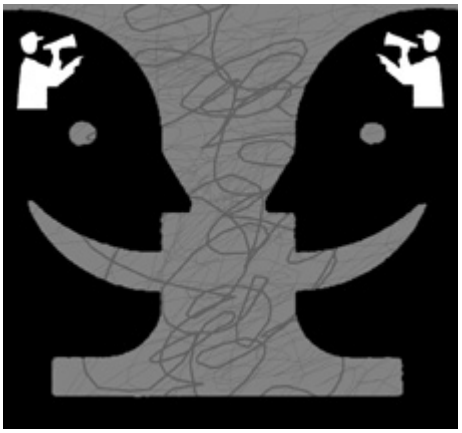
F) el filtrado.- Es la manipulación de información por parte del emisor, de modo que sea vista de manera más favorable por el receptor.

G) la percepción selectiva.- Contrariamente al anterior, esta barrera mental se encuentra en el receptor y consiste en captar sólo aquello que se quiere o sólo lo que conviene al receptor.

H) las emociones.- Conviene hablar aparte de esta barrera personal, porque el estado de ánimo tanto del que emite, como del que recibe, es una interferencia muy poderosa que influye generalmente en la forma que se transmite un mensaje (las emociones afectan el tono de voz, los movimientos, la gesticulación), y también influyen en la forma como se interpreta un mensaje.

I) el lenguaje.- La edad, la educación, el nivel cultural y muchas veces la capacidad o nivel de inteligencia de las personas, son variables que influyen en el lenguaje que utilizan y que son capaces de comprender.

En comunicación, se denomina RUIDO a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir



- Esta consiste en el intercambio del mensaje entre los individuos.
- Es un factor que perturba, interfiere o crea una situación confusa en la comunicación.
- El ruido se debe a múltiples causas:
- El ruido son las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión, la alteración de la escritura en un viaje.
- El malestar físico ,el hambre ,. El dolor o fatiga, también pueden considerarse una forma de ruido y pueden impedir una comunicación satisfactoria.

1.3.- Pautas para mejorar la comunicación con la persona usuaria: claridad, sencillez, atención, empatía.

Establecer una comunicación fluida con los usuarios en el entorno de la institución nos va a permitir mejorar y reforzar nuestra relación con ellos, además de fomentar comportamientos y actitudes de autonomía personal, elevar los niveles de integración y adaptación al contexto residencial y estimular las capacidades y habilidades que el sujeto posea. Por estas razones, es de vital importancia aprender a construir vínculos afectivos y comunicativos efectivos.

Algunas de las actitudes fundamentales que no sólo facilitan el proceso de la comunicación con los usuarios sino que, además, crean la atmósfera de confianza necesaria para construir una relación terapéutica, son:

Claridad.

Enviar mensajes directos, evitando cualquier otra información que pueda desvirtuar el contenido.

Transmitir de forma clara la información, enviando comunicaciones amenas y bien articuladas; es decir, expresadas con buen ritmo y pausas; y con adecuada entonación, según el contenido; etc.

Sencillez.

Usar frases que no se presten a dobles interpretaciones y resumir las ideas en oraciones cortas. Se trata de que el lenguaje oral esté al alcance de la persona receptora, sea breve, conciso y con palabras fáciles de comprender y recordar.

Atención.

Emitir mensajes precisos cuya información resulte estimulante para el paciente, de este modo, el usuario comprenderá mejor lo que pretendemos transmitir. Evitar las “muletillas” y las palabras difíciles o sin sentido para que no aparezcan distracciones. Ilustrar la información a comunicar con ejemplos prácticos o con gestos corporales.

Empatía.

La empatía es la habilidad para comprender a otras personas, por lo que resulta idónea para los contactos interpersonales. Tener empatía supone disponer de la sensibilidad psíquica para detectar las señales externas que nos indican lo que la persona dependiente necesita o quiere. Es una habilidad emocional esencial para

las relaciones sociales, en general y, de forma muy especial, en el desempeño profesional con personas con discapacidad.

Otros componentes en el lenguaje verbal oral que afectan a la recepción adecuada de los mensajes son el volumen, la entonación, la pronunciación y la velocidad.

Existen estrategias o técnicas específicas para conseguir una comunicación exitosa. Entre las más significativas se encuentran:

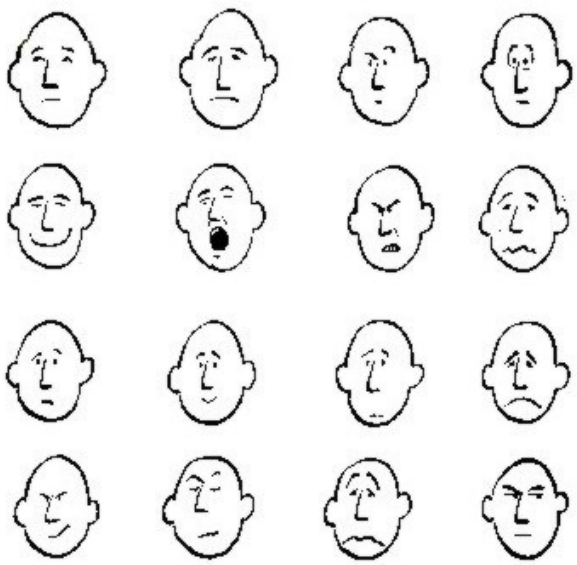
1. la consecución de la escucha activa;
2. la utilización de una actitud empática y
3. el uso de habilidades asertivas.

1.4.- Técnicas básicas de comunicación no verbal.

Las formas no verbales de comunicación son, entre otros, las luces, imágenes, los sonidos, los gestos, los colores y los sistemas simbólicos☹las señales, las banderas y otros medios técnicos visuales).

LENGUAJE GESTUAL Y CORPORAL

En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas (muecas, señales con brazos, manos, dedo, direcciones de pies, miradas), que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. Se han llegado a analizar hasta 16 gestos de emociones en el rostro que pueden entenderse universalmente en las más diferentes culturas.



También existen otras señales realizadas con otros miembros. La comunicación corporal, antes que lenguaje en términos evolutivos, es una parte esencial del sistema de comunicación, y el vehículo para muchas transacciones humanas fundamentales que el discurso sólo no puede comunicar. El lenguaje del cuerpo es una esfera que muchas personas han utilizado para establecer en cada momento unas pautas de actuación o una línea a seguir en determinados escenarios, sean cotidianos, laborales o sociales.



LENGUAJE VISUAL

El lenguaje visual comprende tanto las señas o indicios simples, como códigos semióticos complejos. Gracias a señas, gestos y miradas, las personas son capaces de transmitir mensajes (emisor), que permiten al receptor saber lo que significan sin ponerse de acuerdo. En este caso, la interpretación de lo que dichas señales pueden significar es altamente dependiente del contexto lingüístico

Por el contrario, los códigos más complejos sólo pueden ser aprendidos y el significado no se determina por reglas exclusivamente pragmáticas, sino que requiere el análisis de una dimensión sintagmática y una dimensión paradigmática (como otros códigos semióticos complejos).

LA MIRADA

La mirada es un elemento fundamental en la comunicación no verbal. No sólo transmitimos información mediante palabras. También los ojos cumplen un papel determinante en el proceso comunicativo.





Enfado

Miedo

Cuando escuchamos, es importante mirar a la cara al interlocutor, aunque no es aconsejable mantener la mirada fijamente durante un largo período, pues puede provocar inquietud y nerviosismo en la persona que está hablando. Por otra parte, la mirada sirve para interactuar y marcar los turnos de palabra en una conversación.

Antes de dar una respuesta, solemos desviar la mirada, haciendo ver que vamos a hablar. O mientras escuchamos atentamente a la persona que se está dirigiendo a nosotros, asentimos con la mirada, haciendo ver que prestamos atención.

PARALENGUAJE

El paralenguaje se refiere a todo tipo de señales concurrentes con una emisión propiamente lingüística que transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística. El paralenguaje son aquellas cualidades no verbales y modificadoras de la voz y también los sonidos y silencios con que apoyamos o contradecimos las estructuras verbales o kinésicas. Intervienen en él los aparatos fonadores y los órganos nasales. La existencia de paralenguaje parece un hecho universal de la comunicación humana cotidiana, aunque las formas específicas que toma la gestualidad o las señales concretas son altamente culturales. Por otra parte el paralenguaje en general admite gradualidad, y no es analizable a diferencia de los mensajes propiamente lingüísticos en unidades discretas combinables.

1.5.- Adaptación del léxico de la institución a las características de la persona usuaria.

Es importante considerar la forma en la que denominamos o describimos al usuario o a su dependencia, como realizamos determinadas comunicaciones a las personas con dependencia, y en general la forma de expresarnos con ellas y en el entorno de la institución.

Por ejemplo si a una residente que nunca termina la comida, al servirle le decimos “Más vale que te lo comas todo, guapa”, ese “guapa” está expresando que estamos

hartos de su comportamiento. Nosotros le hemos asignado un significado negativo a una palabra positiva (guapa).

Tenemos que saber que algunos términos que empleamos poseen connotaciones negativas que hacen sentir mal a la persona y que afectan a su autoestima y a su estado de salud.

Por ejemplo, la palabra "viejo" tiene una connotación negativa, aunque no se utilice con esa intención, por lo que utilizaremos otros de carácter neutral "persona mayor" "persona de tercera edad". Otros términos como "discapacitado" o "enfermo" definen de manera directa al usuario, lo correcto es separar a la persona de su condición de dependencia o enfermedad (primero es la persona y después su condición, "persona con discapacidad", "persona que tiene una enfermedad". Otros términos inadecuados "Deficiente mental" por "persona con discapacidad intelectual o psíquica", "mongólico" por "persona con síndrome Down", "psiquiátrico" por "hospital de salud mental".

Es importante que el personal se informe de cuál es la forma adecuada de dirigirse a los usuarios según su dependencia, características personales y el entorno en el que se va a trabajar.

Igualmente es importante utilizar un vocabulario técnico correcto, pero acompañarlas de explicaciones, puesto que de lo contrario no se comprende la información que queremos transmitir.

Otro aspecto importante es disponer de tiempo suficiente para el usuario, para que pueda asimilar la información que le damos. Hay que atender y contestar a sus dudas para completar toda la información sobre su dependencia o enfermedad. Con ello conseguiremos comunicarnos con él de forma comprensible, aumentando su seguridad y mejorando el proceso de comunicación y la relación entre él y el personal del centro.

Llamarles por su nombre hace que aumente su autoestima, ya que le hacemos saber que nos referimos a ellos y que son importantes para nosotros...

Deberemos emplear un lenguaje positivo, que motive, intentando evitar las frases negativas, como por ejemplo en vez de decirle "No te muevas "resulta más eficaz decirle "permanece quieto".

Así mismo debemos evitar frases como "no se puede hacer nada" "es imposible" centrándonos en lo que puede hacer

Debemos poner al alcance de la persona usuaria los recursos materiales necesarios, disponer de todos los instrumentos y herramientas que garanticen la cobertura de las necesidades comunicativas a los



usuarios en cualquier momento o situación. Por ejemplo, amplificadores de sonido, gafas de la graduación correcta, etc.

El ambiente será adaptado para facilitar la comunicación en su distribución debe primar la organización, la sencillez, el orden y la seguridad, ya que estos factores disminuyen los riesgos de accidentes y golpes y además favorecen la confianza de la persona en sí misma y la autonomía personal. Deberán estar bien iluminados

En relación a la comunicación, el entorno debe ser rutinario y estable, porque es prioritario para fomentar su autonomía, mantener sus habilidades y protegerlos frente a posibles accidentes. Las mayores modificaciones deben realizarse para personas que presenten dificultades en la orientación temporal y espacial, y en la atención y la memoria. Entre otras podemos citar:

- Reducir en lo posible sus objetos personales y mantenerlos siempre en mismo lugar con el objetivo de crear una rutina y facilitarles su localización.
- Colocar relojes y calendarios en la pared con números grandes y fáciles de leer.
- Hacer uso de informaciones gráficas (carteles, dibujos, flechas que señalen direcciones o recorridos…).
- Colocar en las puertas de las dependencias carteles con dibujos sencillos que indiquen las tareas o actividades que se realizan en cada una de ellas (cuarto de baño, comedor…).
- Colocar etiquetas con dibujos sencillos en las puertas de armarios y cajones que les facilite la identificación del contenido de los mismos.

1.6.- Comunicación con los familiares y el entorno de la persona usuaria.



La familia es muy importante para la persona dependiente y en general el vínculo afectivo que mantiene con ella es más fuerte que la que mantiene con otros grupos social. Por ello debemos de cuidar la relación entre la institución y la familia del usuario dándole y orientándole en la información que precise. De igual forma la familia resulta una fuente de información para la institución. El usuario va a percibir y captar de forma positiva la coordinación entre familia e institución.

La información básica y más importante que se le va a transmitir a la familia del usuario es la información sobre los protocolos de actuación, cuáles son los más adecuados y frecuentes para su caso particular y e qué consisten. Esto hace partícipe a la familia de la planificación de intervención con el residente, aumentando su sensación de control sobre la situación.

Igualmente hay que comunicar a la familia informaciones sobre la adaptación del residente al centro, estado de ánimo y de salud, progresos o evolución de su dependencia, las relaciones con otros compañeros y otros datos relevantes.

Estas comunicaciones deberemos realizarlas de forma clara, transmitiendo tranquilidad cuando las noticias sean negativas y haciendo uso de expresiones no verbales que reafirmen la actitud comunicativa. Deberemos demostrar apoyo emocional. Nunca dar una información y marcharnos inmediatamente, sino esperar a sus respuestas y atender a sus consultas.

Además la comunicación con la familia cumple la función de asesoramiento favoreciendo la comunicación de la persona dependiente con ellos mismos e intentando corregir actitudes negativas que pudieran estar manteniendo.

A veces, la familia decide mantener a los niños pequeños alejados de la situación, pensando que les desagradaría, sin embargo la compañía infantil puede transmitir alegría y disminuir la seriedad y tensiones, beneficiando tanto a la normalización de la situación familiar, como al estado de ánimo del usuario. Así el personal del centro se lo comunicará a la familia.

En el caso de que la persona dependiente no mantenga relación con la familia, podemos acudir a amigos, vecinos... los cuales pueden intervenir reforzando el apoyo psicosocial hacia el usuario.

Existen una serie de valores que deben guiar la práctica psicosociosanitaria dentro de la institución, en el ámbito de las relaciones con los familiares, con el objetivo de alcanzar una atención de calidad tanto para el usuario como para su grupo familiar:

- Principio de individualización: cada unidad familiar es única y presenta necesidades propias, por lo que deberán ser atendidas de forma personalizada y respetando su ritmo, así como sus particularidades socioculturales.
- Principio de orientación a las necesidades: los profesionales atenderán de forma rápida y efectiva a las demandas y expectativas surgidas desde la

unidad familiar, anticipándose a la aparición de nuevas necesidades y evaluando la satisfacción lograda.
- Principio de referente afectivo: la familia debe ser valorada como un elemento afectivo clave para la persona dependiente.
- Principio de coordinación: el programa de apoyo establecido para la unidad familiar debe estar en consonancia con el tratamiento individualizado del usuario.
- Principio de comunicación continua: el centro establecerá los dispositivos oportunos para informar y asesorar a la familia puntualmente de la atención que se presta a su familiar, contando con su participación y colaboración y de forma expresa escuchando y respetando sus opiniones.

2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa (CCA)

Un sistema de CAA, hace posible que la persona usuaria con necesidades especiales de comunicación, mantenga una relación comunicativa con las otras personas de su entorno.

Para facilitar la comunicación, se diseñan programas de intervención que potencien al máximo las capacidades comunicativas: el habla residual; los gestos; la comunicación a través de signos gráficos (pictogramas), de las tecnologías de apoyo (comunicadores) y de los sistemas del acceso al ordenador. En esta actuación, tiene primordial importancia la participación activa de todos los miembros del entorno social que rodea a la persona con necesidades especiales de comunicación.

Las dificultades pueden surgir en cualquier edad, desde el nacimiento hasta la edad adulta y la población que puede requerir una intervención multidisciplinar en este sentido, es muy heterogénea: parálisis cerebral, autismo, deficiencia mental, afasias, disfasias, demencias, enfermedades degenerativas, daño cerebral. etc.

Los objetivos de la comunicación aumentativa y alternativa son:

- Suministrar un medio de comunicación alternativo hasta que se restablezca la comunicación hablada de forma adecuada.
- Aportar un medio de comunicación alternativo de por vida, cuando no es posible o funcional la comunicación hablada del sujeto.
- Servir como medio de apoyo al desarrollo o al restablecimiento de la comunicación hablada.

En este enlace podéis visionar un video sobre el tema http://www.youtube.com/watch?v=S-MZNtJM8Ig

2.1.- Necesidades especiales de comunicación.

Por necesidad especial de comunicación entendemos las dificultades presentes en una persona para tener acceso a las relaciones con los demás y a la información, y que se derivan de una discapacidad y deben ser compensadas mediante apoyos externos.



La incapacidad para la comunicación conlleva un importante aislamiento social.

Existen múltiples trastornos y enfermedades que pueden afectar en mayor o menor grado a las capacidades comunicativas de la persona, son los principales trastornos de la comunicación y el lenguaje.

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE

Los principales trastornos de la comunicación y el lenguaje pueden afectar aspectos concretos implicados en ellos (la articulación de sonidos, la voz o la fluidez) o a procesos para su adquisición o desarrollo. Igualmente, pueden deberse a factores; o bien a patologías o síndromes (autismo, Parkinson, esclerosis múltiple,…) o a déficits sensoriales (auditivos, visuales,…).

Los más habituales son:

Trastornos de la articulación del habla, son las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas entre ellas están .

- Las *disglosias* son los trastornos de la articulación de los fonemas por alteraciones orgánicas de los órganos del habla y de origen no neurológico central.
- *Disartria* es trastorno del habla cuya etiología se atribuye a una lesión del sistema nervioso central y periférico
- *Rinolalia* es la alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos, asociada un timbre nasal de la voz (nasalización) o timbre muerto (oclusión oclusión nasofaríngea), por deficiencias en la inervación del velo del paladar, por falta de funcionalidad del mismo o por procesos que provocan oclusión nasofaríngea

Trastornos de la fluidez del habla.

- *Disfemias* son alteraciones del lenguaje caracterizadas por tropiezos, espasmos y repeticiones (tartamudez)
- *Taquifemia* es la una alteración de la fluidez verbal, en la que el individuo habla a gran velocidad, articulando de forma desordenada y confusa, produciendo cambios en las sílabas y deformando sonidos.
- *Mutismo*.

Trastornos de la voz

- *Disfonía* es el trastorno de la voz cuando se altera la calidad de ésta en cualquier grado pero se siguen emitiendo sonidos (voz ronca).
- *Afonías* cuando no se emiten sonidos

Trastornos del desarrollo del lenguaje.

- Retraso del habla.
- Retraso del lenguaje.
- Disfasia o la inhabilidad para usar el lenguaje

Trastornos adquiridos del lenguaje.

- *Dislexia* es la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta.
- *Disortografia* es el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía
- *Disgrafía* a la dificultad para una correcta escritura en su grafía
- *Discalculia* es la dificultades en el aprendizaje de las matemáticas



Alteraciones del lenguaje y de la comunicación asociadas a síndromes complejos como el autismo.

Alteraciones del lenguaje y de la comunicación asociadas a síndromes orgánicos:

1. Demencia tipo Alzheimer.
2. Parkinson.
3. Esclerosis múltiple.

Deficiencias intelectuales.

Deficiencias motoras.

Déficits sensoriales:

- Déficits auditivos y/o
- Déficits visuales.

2.2.- Estrategias y recursos de intervención comunicativa.

Como ya hemos dicho, las técnicas de comunicación alternativa y aumentativa son la intervención psico-sociosanitaria de personas con déficits, más eficaz.

Las estrategias de intervenciones en la aplicación de estas técnicas, van a depender de la discapacidad de cada sujeto, así como de los trastornos del lenguaje que se asocien a la misma.

Aún cuando las estrategias varían en función del problema que se quiera subsanar, en general deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser funcionales y no meros marcos teóricos
- Ser espontáneas, esto es, que doten a la persona dependiente de habilidades para iniciar una interacción comunicativa
- Ser extensibles a diferentes entornos y con multitud de personas.

Tras decidir poner en marcha una técnica de intervención psico-sociosanitaria en personas con necesidades específicas de comunicación las estrategias tendrán en cuenta lo siguiente:

1. Planificar y ejecutar las intervenciones sobre la base de las capacidades que el sujeto mantiene y teniendo en cuenta sus dificultades. Cada intervención ha de ser individualizada y personalizada, atendiendo a las necesidades comunicativas del sujeto: de producción vocal, de comprensión, de dicción o entonación, de respiración, de fonación, de entrenamiento en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SCAA). No obstante, siempre habrá de tenerse en cuenta que la finalidad última de toda intervención es lograr una comunicación funcional y pragmática.
   Así, en los sujetos sin lenguaje oral la intervención se centrará en el fomento de la interacción comunicativa y en el entrenamiento en SCAA. En sujetos con lenguaje oral, las estrategias deberán ir orientadas al aumento cuantitativo y cualitativo de las producciones orales.
2. Entrenar en el valor comunicativo del lenguaje.
3. Es prioritaria una participación cooperativa del equipo multidisciplinar, de la familia y del sujeto.
4. Las estrategias de intervención deben distribuirse en entrenamientos individuales y grupales, en los que se van a fomentar y a reforzar las habilidades de interacción comunicativa.
5. Las intervenciones han de llevarse a cabo en un entorno agradable.

6. Deben realizarse de manera diaria, continua e intensiva, buscando la generalización a todos los contextos cotidianos del sujeto.

En el punto 3.2.- Transmisión de la información. Utilización de lenguajes adecuados a las necesidades de las personas usuarias dependientes del apartado 3 de la UF2 del MF1, ya se describieron varias estrategias de intervención. Reléelas de nuevo si no las recuerdas

2.3.- Sistemas alternativos de comunicación:

Tal y como venimos comentando, existen sistemas y estrategias que sustituyen al lenguaje verbal y que se convierten en herramientas muy eficaces para superar las barreras comunicativas, acceder a la información y establecer interacciones de calidad con el entorno: éstos son los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SCAA).

Concepto y clasificación.

CONCEPTO

La comunicación aumentativa y alternativa es el conjunto de formas, estrategias y métodos de comunicación utilizados por personas con discapacidades específicas que no les permiten la comunicación a través del lenguaje y/o del habla.

Cuando un SCAA sustituye en su totalidad al lenguaje oral hablamos de sistema de comunicación alternativo, mientras que si sólo complementa al lenguaje oral incrementando y estimulando la producción verbal, estamos ante un sistema de comunicación aumentativo.

Los pacientes que demandan la implantación de un SCAA lo hacen por alguna de las siguientes causas:

- Carecer de lenguaje oral, pero si poseen la capacidad de comunicar. Pueden ser afectados de parálisis cerebral sin déficit intelectual o sordera.
- Aun manteniendo las capacidades lingüísticas intactas, carecen de la capacidad de comunicar. Puede ser el caso de personas con trastornos del espectro autista.
- Presentar alteraciones en el lenguaje oral unidas a problemas comunicativos. Sería el caso de personas con trastornos graves del desarrollo.
- no presentar alteraciones en el ámbito comunicativo pero carecer de un nivel de lenguaje oral aceptable en cuanto a criterios de funcionalidad. Sería el caso de personas con déficits motores.

Por lo tanto la clasificación de las SCAA se dará en función de la causa que los determina.

CLASIFICACIÓN

Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa sin ayuda.

Son aquellos en los que el sujeto emisor no necesita apoyos materiales externos, y sólo utiliza su cuerpo, sus habilidades y sus capacidades para configurar y transmitir el mensaje. Principalmente, son gestos y signos manuales.

De entre estos los más usados son: la lengua de signos, el alfabeto dactilológico, la palabra complementada y el sistema Bimodal (ver nuevamente el punto 3.2 de la UF2 del MF 1)



Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa con ayuda.

Hablamos de SCAA con ayuda cuando éstos necesitan de un apoyo externo a la persona. Son aplicables a personas con graves déficit motores y a personas con dificultades cognitivas o de aprendizaje. Por ejemplo, los sistemas pictográficos (basados en fotos o dibujos de objetos), BLISS, Rebus, PIC, Premack y el Sistema de lectoescritura Braille

Uso del vocabulario básico de la atención sociosanitaria en instituciones de atención social en los lenguajes alternativos usuales: BLISS, SPC y LSE.

Los principales lenguajes alternativos utilizados en los entornos sociosanitarios con personas con dificultades de la comunicación y el lenguaje se desarrollan con mayor profundidad en este apartado, y son los siguientes:

A. Lengua de Dignos Española (LSE).

Aunque ya hicimos referencia a él en el apartado 3.2 de la UF 2 del MF1 lo retomaremos para tratarlo un poco más.

La lengua de signos española (también llamada, aunque menos frecuentemente, lengua de señas española), LSE, es la lengua gestual que utilizan principalmente los sordos españoles y personas que viven o se relacionan con ellos.

Tradicionalmente la lengua de signos se ha considerado mimo o pantomima, pero si así fuera, las personas que no conociesen esta lengua comprenderían sin mayor problema a las personas sordas en sus intercambios comunicativos.

Otro de los tópicos extendidos es el de creer que la lengua de signos tiene un carácter universal, pero no es así, hay diferencias entre unos países y otros, e incluso dentro de un mismo país hay diferentes variedades.

De la misma forma que las personas oyentes no se cansan de utilizar la lengua o los labios, las personas sordas no se cansan de hablar con sus manos. Y los sordos tienen fama de hablar mucho entre ellos.

En el siguiente enlace puedes encontrar un diccionario del LSE http://www.sematos.eu/lse.html

B. Sistema SPC (Picture Communication Symbols).

Los Símbolos Pictográficos para la Comunicación, representan de una forma bastante clara las palabras y conceptos más habituales en la comunicación cotidiana.

Está especialmente indicado para personas que, debido a su discapacidad (Autismo, PCI, Daño Cerebral Sobrevenido,…), tienen limitadas sus competencias comunicativas: manifiestan un nivel de lenguaje simple, un vocabulario limitado y elaboran estructuras de frases muy cortas.

Además, para determinar si el sistema SPC es oportuno para un sujeto en concreto, deberemos valorar que dispone de unas mínimas habilidades:

- Deberá tener un mínimo de necesidades de comunicación (intencionalidad comunicativa).
- Dispondrá de buena agudeza visual y perceptiva.
- Manifestará unas mínimas habilidades cognitivas.

Los símbolos SPC viene agrupados por categorías (Personas, Verbos, Nombres,…) y cada categoría tiene asociada un color.

En este enlace puedes ver cuáles son estos símbolos y que color les corresponde.

http://disfasiaenzaragoza.com/pictogramas/ficheros/SPC%20Indice%20Tematico.pdf

Las siguientes imágenes son un ejemplo y se recomiendan en rosa o morado.



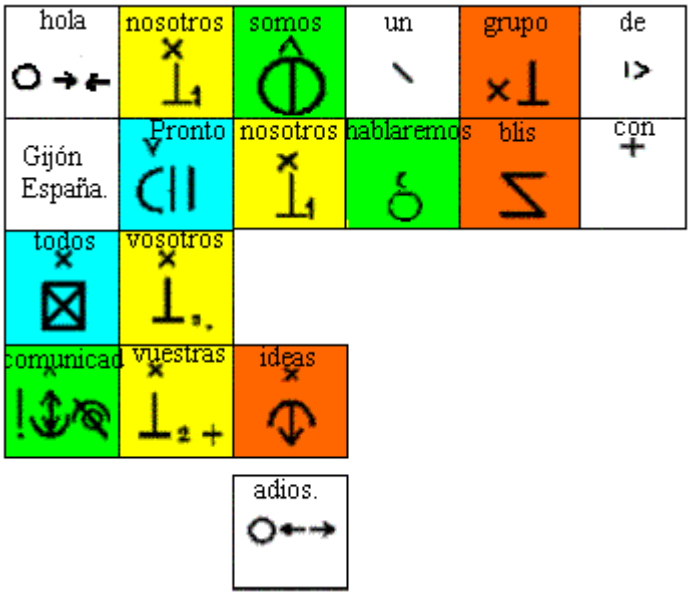
C. Sistema Bliss.

Algunos niños y adolescentes (generalmente con serios trastornos del habla) han pasado toda su etapa escolar sin adquirir la lectoescritura, esto es, por algún motivo no llegan a codificar símbolos basados en el alfabeto corriente. Sin embargo muchas de estas personas demuestran día a día que disponen de altas competencias comunicativas.

Para ello, el Sistema Bliss puede ser una alternativa ideal: ofrece un conjunto restringido de símbolos pictográficos e ideográficos que permiten representar infinidad de palabras e ideas.

Cada símbolo está formado por uno o más elementos. Las variaciones sobre el tamaño, posición, orientación o número de elementos de un símbolo, introducen más posibilidades de expresión. Otra característica del Sistema Bliss es que permite realizar un uso creativo del lenguaje: un usuario de Bliss puede combinar uno a más símbolos para crear un nuevo significado.

Este sistema de comunicación está muy ligado a personas con Parálisis Cerebral. De hecho se empezó a experimentar con éxito en Canadá, en la década de los setenta del siglo pasado, en un centro escolar de niños con Parálisis Cerebral.



Tanto este sistema como el anterior forman parte de los PECS (Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes

Si quieres conocer más sobre los PECS haz clic en el siguiente enlace:
http://www.esaac.org/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=45

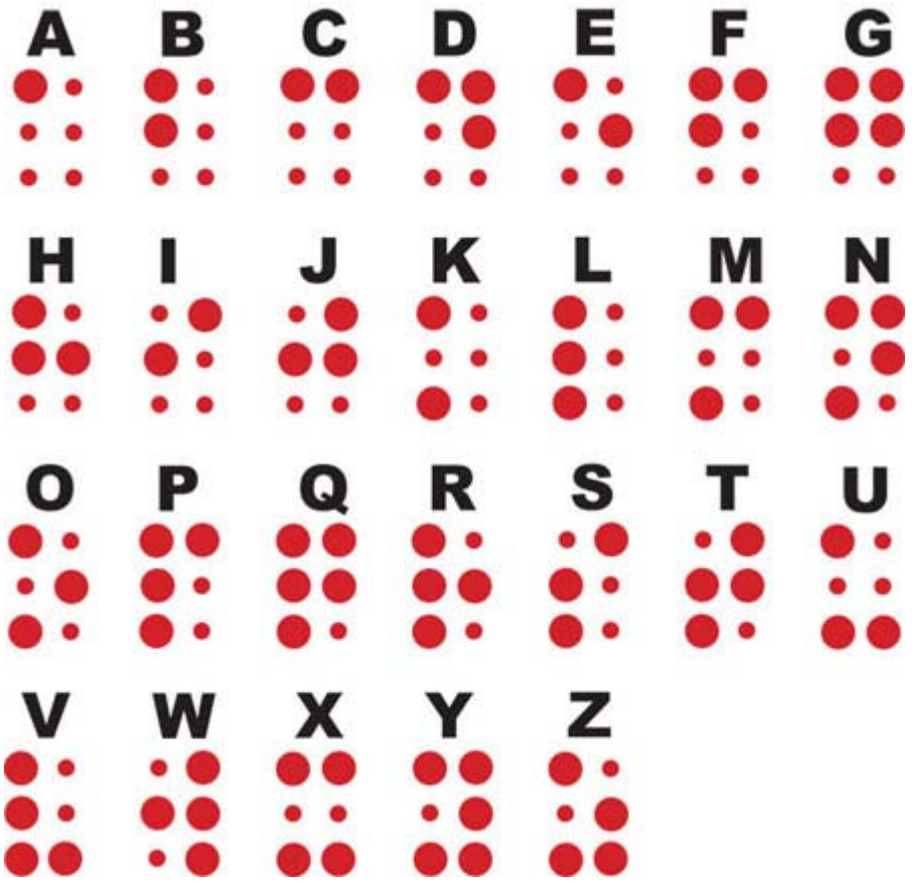
D. sistema Braille

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de París (donde estudiaba el joven Braille) le pidió que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Louis Braille descubrió al cabo de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de ocho puntos. Al cabo de unos años lo simplificó dejándole en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.

El braille resulta interesante también por tratarse de un sistema de numeración binario que precedió a la invención de las computadoras.

Los ciegos leen por el tacto, al deslizar sus dedos sobre un alfabeto especialmente ideado para ellos.

.



2.4.- Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa.

Las ayudas técnicas para los SCAA son los productos de apoyo utilizado por personas con alguna discapacidad para compensar o neutralizar la deficiencia, las limitaciones en la actividad y la falta en la participación. En este caso para poder desarrollar la comunicación en el medio que rodea a la persona.

El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas: CEAPAT, es el encargado de ofrecer información, evaluación de ayudas técnicas y accesibilidad, su asesoramiento es gratuito. (Pertenece al IMSERSO).

La tecnología de ayuda sólo sirve como apoyo formativo o de aprendizaje del método SCAA utilizado.

Entre otros recursos tenemos:

1. El tablero de comunicación permite cambiar de lugar los símbolos rápidamente. Los tableros consisten en superficies sobre las que se disponen los signos que las personas, necesitan para comunicarse, los hay portátiles o no. Los tableros se personalizan



2. Señalador de Reloj es un dispositivo similar a un reloj convencional en el que la aguja señala símbolos o imágenes colocadas a su alrededor
3. Comunicador con pictogramas en el que mensajes grabados se asocian a pictogramas de las casillas





4. Adaptadores para el ordenador: teclados alternativos para el ordenador, tarjetas de voz, sintetizadores de voz, pulsadores (para la señalización directa: licornio que se coloca en la cabeza, varilla bucal, pulsadores de soplo, de vibración, de parpadeo...).
5. Programas que permiten utilizar el Bliss y el SPC
6. Máquina Perkins para escribir en Braille,



Línea Braille, Impresoras en Braille, El Screen Braille Comnuicator (se trata de aparatos con doble teclado y doble display, uno en braille y otro con caracteres convencionales, de forma que la persona sordociega puede introducir

información por el teclado braille y este aparece en el display de caracteres convencionales)




7. Lectores de DAISY que permiten reproducir audio libros, son escáneres sonoros.



8. Los generadores de voz son aparatos de ayuda para el habla que permiten tener una locución agradable, comprensiva y sobretodo natural a las personas que han perdido la voz a causa de un accidente.



9. Pantallas de ordenador de mayor tamaño
10. Magnificadores de pantalla o lupas para ordenador y televisión
11. programas informáticos que agrandan el tamaño de la letra
12. Lectores de pantalla
13. Teléfonos de texto (OTICON) para sordos



14. Fax
15. Videoteléfonos
16. Teléfonos móviles
17. Internet

Para ver más productos haz clic en este enlace http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/22 .

2.5.- Técnicas de comunicación con enfermos de alzhéimer.



La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo del cerebro, caracterizado por cambios degenerativos de las células nerviosas corticales y de las terminaciones nerviosas cerebrales.

Este proceso produce un deterioro irreversible de la memoria y la destrucción de las funciones intelectuales.

Las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen problemas en entender el significado de lo que se dice. Sin embargo, son muy sensibles a la forma en que se dicen.

Un tono agitado puede mortificarlo; un tono calmado puede reconfortarlo.

Mantenga un tono positivo de voz tanto como pueda. Los siguientes consejos también le pueden ayudar a comunicarse mejor.

COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO DE ALZHEIMER

- Acercarse a la persona de frente y lentamente.
- Hablar lenta y claramente.
- Utilizar frases cortas y palabras familiares.
- Acompañar el habla con gestos ligeramente exagerados y valiéndose de la expresión facial y otros signos de comunicación no verbal.
- Reducir ruidos de fondo y otras posibles distracciones.
- Intentar no saltar de un tema a otro en la conversación.
- Si la persona habla despacio o tiene dificultades para encontrar las palabras, resistir la tentación de hablar por ella o de terminar sus frases. Dar tiempo para que transmita lo que intenta decir.
- No fingir que se ha entendido el mensaje si no lo ha hecho, porque esto produce frustración en las dos partes.
- Potenciar cualquier otro sistema de comunicación (visual, propioceptivo, con sonidos no verbales...).

PAUTAS DE ACTUACIÓN

- EVITAR SITUACIONES EN LAS QUE SE REQUIERA EL RAZONAMIENTO: razonar coloca al individuo en un papel adverso en el que está forzado a defender su posición (al tiempo que cuenta con pocos recursos para ello), lo cual le hará sentirse mal y colocarse a la defensiva. La respuesta puede ser con frecuencia no.
- ESCUCHAR AL INDIVIDUO: Todo individuo, sea cual fuere su situación, tiene la necesidad de comunicarse. Una escucha activa puede ayudarle a responder de forma positiva.
- MANTENER UNA RELACIÓN DE SINCERIDAD: Evitar dar una información errónea o hacer falsas promesas. Mantener la cortesía en todas las ocasiones.
- OFRECER ELECCIÓN SIEMPRE QUE SEA POSIBLE: Ayuda a mantener, en la medida de lo posible, el sentido de autonomía, independencia y control de la situación. (No se ofrecerán más de dos opciones; en ocasiones sólo una opción).
- COMUNICAR CON EFECTIVIDAD: Minimizar la desorientación del paciente. La información relevante es aquella necesaria para facilitar el cuidado en el momento presente (por ejemplo: “hoy hace frío; necesitará ponerse un jersey”.)

- TRATAR AL PACIENTE COMO A UN INVITADO QUE NO SABE DÓNDE ESTÁ

En este enlace tenéis un video resumen sobre las variaciones de carácter de las personas con alzhéimer: http://www.youtube.com/watch?v=ooPpD2h8bMQ&feature=player_embedded

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

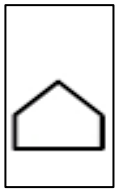
1. ¿Qué es la comunicación?
2. Elementos que intervienen en la comunicación
3. Completa las frases con las siguientes palabras:

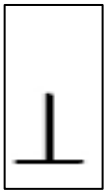
   Asegurar empatía atención sencillez claridad

a) La……..Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro
b) La……...posibilita comprender el mensaje que la persona dependiente está emitiendo.
c) La función de la retroalimentación ……..que el mensaje ha llegado
d) La…… y…….. son conceptos que hacen mejorar la comprensión del mensaje

4. Explica brevemente como refuerzan la comunicación no verbal (gestos, postura, miradas..) al lenguaje verbal
5. Pautas básicas o estrategias para comunicarse con las personas con Alzheimer
6. Indica a que Sistema de Comunicación Alternativa y Aumentativa (SAAC)pertenecen las siguientes imágenes



7. Explica cómo utilizarías los elementos de comunicación no verbal para aproximarse al usuario en estos dos casos:
   a) Un residente está llorando porque esperaba una visita que no ha llegado
   b) Un residente con déficit auditivo que ha tirado la cena porque está enfadado con su compañera de mesa.
8. Ana, una técnico socio sanitaria necesita hablar con Fernando (residente de una institución) para comunicarle un cambio de horario en las actividades de ocio programadas en el centro. Ana está nerviosa porque una compañera ha

faltado y el trabajo se acumula. Fernando está en una sala de uso común donde la TV. Con el volumen alto. Fernando está receloso porque hace un par de día Ana le dio una mala contestación.

Ana le transmite la información a Fernando y continúa con sus tareas.

Al día siguiente Fernando no acude a las actividades de ocio, por lo que el técnico responsable le pregunta por qué no ha ido, a lo que contesta “Nadie me avisó”

9. Señale las barreras de comunicación y qué haría usted para eliminarlas
10. De las siguientes afirmaciones, cuáles son verdaderas y cuáles falsas

a. En las barreras comunicativas de tipo físico se integran aquellas distorsiones que emisor o receptor hacen de los mensajes debido a estados emocionales o déficit de tipo cognitivo.
b. El concepto comunicación no verbal hace referencia a la información que se transmite al receptor sin palabras, por medio del cuerpo, movimientos y sonidos.
c. La Kinesia se vincula a la distancia física entre las personas participantes en una interacción comunicativa.
d. la asunción de un rol paternalista por parte del profesional, constituye una barrera comunicativa que frecuentemente tiene lugar en la relación con personas con discapacidad.
e. Las estrategias para entablar comunicaciones eficaces más significativas son dos:escucha activa y utilización de habilidades asertivas.
f. Dentro de las técnicas asertivas, la del disco rayado consiste en dar la razón al interlocutor en las críticas acertadas que hace, pero sin polemizar con él.
g. La empatía implica una actitud para asumir el estado emocional y la situación de otra persona sin prejuicios, y hacérselo saber

11. Define Necesidad Especial de Comunicación
12. ¿Qué requisitos debe cumplir un SCAA para cubrir las necesidades de comunicación del sujeto?
13. Completa las siguientes frases:

Los SCAA _____ ayuda dependen de _____ materiales _____ al cuerpo del sujeto.
La _____ es el lenguaje _____ de las personas sordas.
El sistema SPC se basa en _____ que _____ la realidad, y se complementa con _____, el alfabeto y los _____
Los _____ Bliss se organizan en categorías según claves de _____
El amarillo se usa para designar a las _____
El término _____ para la comunicación Aumentativa y Alternativa hace referencia a cualquier artículo, equipo global o parcial, adquirido

comercialmente o adaptado a una persona con la finalidad de que esta pueda _____ mejor, ya sea aumentando o supliendo su _____ oral.